

Relación céntrica y oclusión céntrica

1. Posiciones mandibulares de referencia

Relación céntrica (RC)

Posición **musculoesquelética estable** de la mandíbula, en la que los cóndilos se sitúan en su posición **más superior y anterior** dentro de la fosa, apoyados contra la vertiente posterior de la eminencia articular, **con el disco articular correctamente interpuesto**. Es una posición **articular**, no dentaria: existe aunque el paciente no tenga dientes. Es **registrable y reproducible**, y por eso sirve como punto de partida para el diagnóstico y para el montaje en articulador.

Oclusión céntrica (OC) o máxima intercuspidación (MIC)

Posición en la que los dientes presentan el **máximo número de contactos** entre sí. Es una posición **dentaria**: la determinan los dientes, no la articulación. Es la posición que el paciente encuentra por sí solo al morder.

Relación céntrica coincidente

Cuando RC y MIC ocurren en la misma posición. Se considera la situación **más favorable**, porque el cierre dentario ocurre justo donde la articulación es estable. Se estima que solo una minoría de la población la presenta de forma natural.

Discrepancia RC–MIC y deslizamiento en céntrica

Cuando ambas posiciones no coinciden, al cerrar en RC aparece un **primer contacto** y la mandíbula **se desliza** hasta alcanzar la MIC. Ese recorrido se llama **deslizamiento en céntrica**. Se describe en tres sentidos: **vertical, horizontal y transversal**. Un deslizamiento pequeño y estrictamente anterosuperior suele tolerarse; uno amplio o con **componente lateral** es el de mayor significado patológico.

2. Contacto prematuro e interferencia

Contacto prematuro

Es el **primer contacto dentario** que ocurre durante el cierre en relación céntrica, antes de alcanzar la máxima intercuspidación. Es un fenómeno de la **posición de cierre**.

Interferencia oclusal

Es el contacto que **obstaculiza o desvía** los movimientos mandibulares **excéntricos** (lateralidad y protrusión), impidiendo un deslizamiento armónico. La diferencia práctica: el prematuro estorba al **cerrar**; la interferencia estorba al **moverse**.

3. Clasificación de las interferencias

Interferencias céntricas

Contactos prematuros en el cierre en RC. Provocan el deslizamiento hacia MIC y, con él, una desviación mandibular repetida en cada deglución.

Del lado de trabajo

Contacto en el lado hacia el que se desplaza la mandíbula, que **impide la desoclusión** armónica de los dientes posteriores. Suele darse entre vertientes internas de cúspides vestibulares superiores y vertientes externas de cúspides vestibulares inferiores.

Del lado de balance o de no trabajo

Contacto en el lado **opuesto** al movimiento. Es la **más lesiva** de todas: se produce en una zona cercana al fulcro articular, donde la palanca genera cargas elevadas, y ocurre además con los músculos elevadores en contracción. Se asocia con dolor muscular y articular.

Protrusivas

Contactos posteriores durante el movimiento protrusivo, que **deberían haber desocluido** por acción de la guía anterior. Indican una guía anterior insuficiente o dientes posteriores sobreerupcionados.

4. Etiología

Causas dentarias

- Caries y pérdida de estructura que modifica la anatomía oclusal.
- **Migraciones por ausencias no rehabilitadas**: inclinación de los dientes vecinos y **extrusión del antagonista**, que es una de las causas más frecuentes.
- Malposiciones y giroversiones.
- Erupción de terceros molares en mala posición.
- Desgastes irregulares que crean facetas no funcionales.

Causas iatrogénicas

- **Restauraciones altas** o sin ajuste oclusal verificado con papel articular.
- Restauraciones con anatomía oclusal deficiente o puntos de contacto mal restablecidos.
- Prótesis fija o removible mal diseñada.
- Tratamientos de ortodoncia sin acabado oclusal adecuado.

Esta categoría es la más relevante para el alumno: es la que él mismo puede provocar o evitar.

Causas periodontales

Movilidad dentaria y **migración patológica** por pérdida de soporte, que modifican la posición de los dientes y generan contactos nuevos.

Causas articulares y musculares

Cambios en la posición condilar por **desplazamiento discal**, remodelado o artropatías, que modifican la relación entre las arcadas. También la hipertonía muscular sostenida.

Causas del desarrollo y esqueléticas

Discrepancias maxilomandibulares y maloclusiones que condicionan una relación oclusal desfavorable desde el inicio.

Hábitos parafuncionales

El bruxismo y el apretamiento no solo son consecuencia: también **generan** desgastes y facetas que crean nuevas interferencias, cerrando un círculo de daño.

5. Consecuencias clínicas

Sobre el diente y el periodonto

Facetas de desgaste, **abfracciones cervicales**, fisuras y fracturas, hipersensibilidad, movilidad dentaria y ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal (**trauma oclusal**).

Sobre el músculo

Hipertonía, fatiga y dolor miofascial, particularmente en masetero y temporal, y en la cadena cervical por compensación postural.

Sobre la articulación

Sobrecarga condilar, alteración de la posición del disco y sintomatología articular.

6. Diagnóstico

Exploración clínica

- **Manipulación bimanual** para llevar la mandíbula a RC sin forzar.
- **Desprogramación** previa (JIG anterior, tope de Lucia o algodón entre incisivos) para eliminar la memoria muscular que lleva al paciente a su MIC habitual.
- **Papel articular de dos colores**: un color para céntrica, otro para excéntricos.
- Observar la **dirección y magnitud** del deslizamiento RC–MIC.

Registros y análisis

Modelos de estudio **montados en articulador semiajustable** con arco facial y registro en RC. Es el único método que permite analizar los contactos sin la influencia de la propiocepción periodontal del paciente, que tiende a evitar el contacto molesto.

7. Esquemas oclusales de referencia

Función canina

En lateralidad, solo los **caninos** mantienen contacto y desocluyen todos los posteriores. El canino tiene raíz larga, buena proporción corona-raíz y abundantes propioceptores.

Función de grupo

El contacto en lateralidad se **reparte** entre varios dientes del lado de trabajo, distribuyendo la carga. Es una alternativa aceptable cuando el canino no puede asumir la guía.

Guía anterior

En protrusión, los **dientes anteriores** deben producir la desoclusión inmediata de los posteriores. Es un mecanismo **protector**: los mecanorreceptores periodontales anteriores inhiben la actividad de los músculos elevadores.

Principio general

En un esquema oclusal favorable: contactos **simultáneos, bilaterales y de igual intensidad** en céntrica, con cargas dirigidas por el **eje axial** de los dientes posteriores, y **desoclusión inmediata de posteriores** en todos los movimientos excéntricos.

Material de apoyo para la asignatura de Oclusión. Complementar con la bibliografía indicada por el catedrático.